SDD 145 Sujet n°1

Spécialité : Médecine générale

Date : 21/01/2024
Auteur : Valentin BRARD (DES médecine générale)
Relecteur(s) : Sébastien VILLARD (DES de médecine interne)/Alexandre Degachi (DES de médecine interne)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie diagnostique
Domaine d'apprentissage secondaire	Iconographie
Item(s) en lien avec la station	149 - Rhinopharyngite et angine
Situation(s) de départ en lien avec la station	145 - Douleur pharyngée 52 - Odynophagie/Dysphagie
Matériel nécessaire à la station	Annexe n°1 : photo d'oropharynx Annexe n°2 : résultat du TROD
Contexte de la station	Cabinet de médecine de ville

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes un·e médecin généraliste en cabinet médical.
Vous recevez madame Tartin, âgée de 19 ans qui présente des maux de gorge depuis 3 jours.
Paramètres vitaux : Température 38.8°C, fréquence cardiaque 110 bpm, Saturation en O2 99% en air ambiant, fréquence respiratoire à 15/min, tension artérielle à 120/80 mmHg.
Madame Tartin est en première année de droit, elle a pour seul antécédent une mononucléose infectieuse il y a quatre ans. La patiente ne prend pas de traitement au long cours.

Consignes :
Vous devez, après avoir pris connaissance de l'annexe, en 7 minutes :

- Compléter l'interrogatoire et l'examen clinique de la patiente de manière orientée
- Justifier la réalisation d'un ou plusieurs examens complémentaires
- Donner le diagnostic final

Vous ne devez pas :

- rédiger d'ordonnance
- réaliser de geste technique

Attention : Vous avez 7 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
GRILLE D'EVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques (13 points)			
1.	Justifie le TROD (MacIsaac) - Absence de toux	1 pt	☐
2.	Justifie le TROD (MacIsaac) - Fièvre > 38 °C	1 pt	☐
3.	Justifie le TROD (MacIsaac) - Adénopathie cervicale sensible/douloureuse	1 pt	☐
4.	Justifie le TROD (MacIsaac) - Examine la gorge de la patiente et annonce une angine érythémato-pultacée	1 pt	☐
5.	Recherche la présence de complications - Trismus ou "difficulté à ouvrir la bouche" *NB : Il est trop tôt pour rechercher le syndrome inflammatoire post-streptococcique.*	1 pt	☐
6.	Recherche la présence de complications - Torticolis ou "douleur aux mouvements de la nuque" *(compter bon si l'étudiant·e recherche une raideur de nuque)*	1 pt	☐
7.	Recherche la présence de complications - Érythème du cou	1 pt	☐
8.	Recherche la présence de complications - Sialorrhée ou "présence de salive en grande quantité"	1 pt	☐
9.	Prescrit un TROD SBHA/ test de diagnostic rapide streptococcique car le score mac Isaac >2	1 pt	☐
10.	Interprète le TROD comme étant positif	1 pt	☐
11.	Annonce diagnostic *(au moins un élément)* : - Angine streptococcique compliquée - Suspicion d'adénophlegmon cervical	1 pt	☐
12.	Diagnostic de la suspicion de complication Indique qu'un scanner cervico-facial injecté est nécessaire	1 pt	☐
13.	Diagnostic de la suspicion de complication Le scanner est à réaliser aux urgences	1 pt	☐
Communications et attitudes (3 points)			

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

14.

1. APTITUDE À ÉCOUTER : le patient / le pair

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Interrompt le patient /pair de façon inappropriée Ignore les réponses du patient/collègue	Se montre impatient	Est attentif aux réponses du patient/pair	Est attentif aux réponses du patient/pair Adopte la technique de reformulation si l'information est imprécise ou éloignée des objectifs.	Porte une attention soutenue aux réponses du patient/pair et à ses préoccupations.

15.

4. APTITUDE À STRUCTURER/ MENER L'ENTREVUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
Approche désordonnée	Entrevue peu structurée, présente les difficultés à recadrer les discussions qui s'éloignent des objectifs	Entrevue centrée sur le problème et couvre les éléments essentiels	Entrevue menée de façon logique, structurée, centrée sur le problème, ne cherche pas l'information non pertinente	Entrevue ayant un but précis, approche intégrée

16.

9. APTITUDE À STRUCTURER L'EXAMEN CLINIQUE

Performance Insuffisante 0 point	Performance Limite 0,25 point	Performance Satisfaisante 0,5 point	Performance Très Satisfaisante 0,75 point	Performance Remarquable 1 point
L'examen clinique est incomplet et désorganisé ou ne fait pas l'examen clinique	Les éléments recherchés sont peu ciblés, s'attarde à des manœuvres inutiles	L'examen clinique est raisonnablement organisé et couvre les éléments essentiels	L'examen clinique suit un enchaînement logique et est centré sur le problème, il n'y a pas de manœuvre inutile	L'examen est réalisé sans erreur avec un but précis, démarche intégrée

TOTAL (16 items)	16 points

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Éléments de rétroaction :

Devant un·e patient·e présentant une angine, il faut :

- d'une part éliminer les complications locales (phlegmon péri-amygdalien, infection pré-stylienne, abcès rétro-pharyngé, adénophlegmon cervical, cellulite cervicale) en rechercher un trismus, une hypersialorrhée, un torticolis fébrile et une médiastinite.
- d'autre part évaluer la nécessité d'un TDR du *Streptococcus pyogenes*.

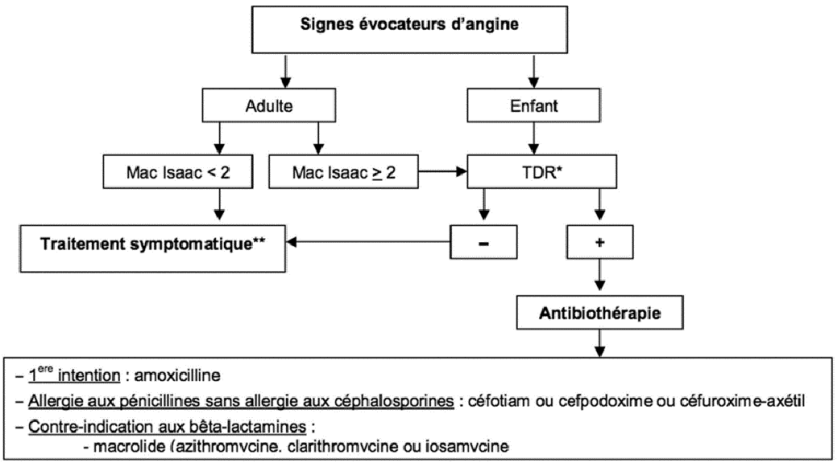
Un enfant de moins de 3 ans ne peut pas présenter une angine à SBHA. Le pic de prévalence de la maladie survient entre 5 et 15 ans.
Entre 3 et 15 ans, le TROD sera systématique, le SBHA représentant 25 à 40% des étiologies d'angine et aucun signe clinique n'ayant de bonne valeur prédictive positive à cet âge.
Après 15 ans, la prévalence des angines bactériennes s'effondre. Les étiologies virales représentent ainsi 75 à 90% des cas observés chez l'adulte. On réalise donc le score de MacIsaac dont la valeur prédictive négative est excellente dans cette population (> 95%).

On retient comme critères du score de MacIsaac :

- La fièvre > 38 °C +1 pt
- L'absence de toux +1 pt
- La présence d'adénopathies cervicales sensibles +1 pt
- La présence d'une atteinte amygdalienne *(augmentation du volume ou exsudat)* +1 pt
- L'âge :
  - entre 3 et 14 ans +1 pt
  - entre 15 et 44 ans 0 pt
  - à partir de 45 ans -1 pt

  Un score supérieur ou égal à 4 est associée à une VPP de SBHA de 51 à 53%*

*Mac Isaac (CAMJ 1998, CAM J2000, JAMA 2004)



* Réalisation du Test de Diagnostic Rapide du streptocoque du groupe A (TDR) systématique chez l'enfant ≥ 3 ans et l'adulte si score de Mac-Isaac ≥ 2
** Antalgique et/ou antipyrétique.

Une fois l'indication du traitement antibiotique posé, il faudra **toujours rechercher un antécédent d'allergie à l'amoxicilline**.

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PATIENT SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Le ou la candidat·e est médecin généraliste en cabinet.

Plan de la station ECOS :

La patiente est face au candidat. Un bureau sépare les deux participants.

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

"Bonjour docteur,
Je viens vous voir parce que j'ai mal à la gorge depuis 3 jours."

Identité du patient :

Femme, TARTIN Céline, 19 ans, 1m70, 60kg

Mode de vie :

Etudiante en première année de droit, joueuse d'échec, célibataire, sans enfant, vit en collocation avec 2 personnes parties en vacance, pas de tabac, alcool occasionnel (2 fois par semaine, 3 verres à chaque fois), **pas d'allergie**. Pas de rapport sexuel à risque.

Comportement global :

Coopérante et sympathique. Fatiguée par la fièvre (38.8 °C), avec un cou douloureux aux mouvements de rotation de la tête ("torticolis").

Antécédents personnels :

Syndrome mononucléosique à EBV. "J'ai fait la mononucléose il y a 2 ans."

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Antécédents familiaux :

La patiente ne connaît pas les antécédents médicaux de ses parents.
→ “Ils vont très bien.”

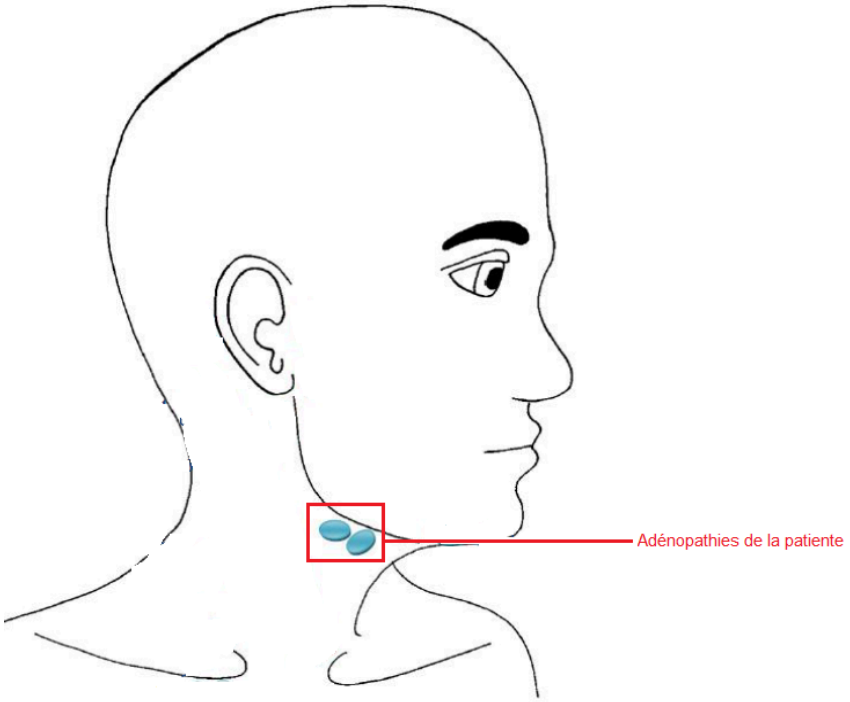
Médicaments :

Pas de traitement de fond.
La méthode contraceptive de la patiente repose sur les préservatifs.

En aigu :
Prise d’un comprimé de paracétamol 1g il y a 6h pour soulager ses douleurs.

Symptômes positifs :

- Si l’étudiant·e demande où se situe la douleur → “Au fond de la gorge et au cou”
- Si l’étudiant·e demande un facteur aggravant la douleur → “J’ai vraiment mal quand j’avale et quand je tourne la tête”
- Si l’étudiant·e demande à voir le fond de la gorge → **lui donner l’annexe n°1**
- Si l’étudiant·e palpe le cou → **adénopathies sous-mandibulaires bi-latérales sensibles** *(douloureuses pour la patiente au passage de la main de l’examinateur)*
- Si l’étudiant·e demande si la patiente a mal au cou ou si le cou a gonflé → “Il n’a pas gonflé mais j’ai des ganglions qui me font un peu mal quand j’appuie dessus et j’ai comme un torticolis.”



TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l’accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Symptômes négatifs :

RÉPONDRE NON QUAND L'ETUDIANT·E DEMANDE SI :

- la patiente a du mal à ouvrir la bouche
- la patiente a mal à la tête
- la patiente a des difficultés à respirer
- le cou de la patiente est devenu rouge ou a gonflé
- la patiente a plus de salive dans la bouche que d'habitude

LA PATIENTE NE TOUSSE PAS et N'A PAS TOUSSÉ depuis le début des symptômes.

Tout autre examen clinique de l'étudiant·e portant sur la sphère ORL, les poumons, le cœur et les autres systèmes aura comme réponse : "Il n'y a pas d'anomalie."

Constantes :

T°38.8, FC 110, Sat 99%, FR 15, TA 12/8

Donnée complémentaire :

- Annexe n°1 : photo d'une angine érythémato-pultacée *(avant-dernière page de ce document)*
  → A remettre quand l'étudiant demande à voir la gorge

- Annexe n°2 : résultat du TROD du streptocoque bêta-hémolytique du groupe A positif
  → A remettre **immédiatement** quand l'étudiant·e annonce la nécessité d'un TROD/Test diagnostic streptococcique en disant "Voici les résultats de l'examen que vous prescrivez."
  → Si l'étudiant·e dit qu'un examen diagnostic n'est pas nécessaire, lui donner l'annexe n°2 en disant. "Un TROD a finalement été réalisé, en voici le résultat."

Questions de relance :

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR (FACULTATIF)

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

Plan de la station ECOS :

La patiente est face à l'étudiant·e, un bureau séparant les deux personnes.
Les annexes n°1 et n°2 ne sont pas remises à l'étudiant·e dès le début de l'épreuve.

Matériel nécessaire à la station :

- IPAD pour examinateur
- Feuille de brouillon pour candidat
- Stylo pour candidat
- Feuille de brouillon pour évaluateur
- Stylo pour évaluateur

Documents présents dans la station :

- Feuilles d'évaluation de papier de secours
- Annexe n°1
- Annexe n°2

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ANNEXE 1

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)

ANNEXE 2

TACFA – Tutorat associatif pour des conférences en formation approfondie en sciences médicales
Toute reproduction même partielle, toute vente sans l'accord du TACFA sont interdites.
Sous la supervision de Clément FILLIOL (VP ECOS, DES radiologie Lyon), Robin ELAYLI (VP ECOS, DES de psychiatrie à Grenoble), Sébastien VILLARD (VP ECOS, DES de médecine interne Paris), Alexandre DEGACHI (président, ancien DES médecine interne Paris)